

1. Introducción y relevancia clínica

La **úlcer**a péptica es una lesión profunda de la mucosa gastrointestinal que se extiende más allá de la muscular de la mucosa y aparece como consecuencia del desequilibrio entre los **factores agresivos** (**ácido gástrico, pepsina, Helicobacter pylori, AINEs**) y los **mecanismos defensivos** de la mucosa (moco, bicarbonato, flujo sanguíneo, regeneración epitelial).

Afecta principalmente el **estómago y el duodeno**, siendo una de las causas más comunes de dispepsia, hospitalización y hemorragia digestiva alta.

La **gastritis**, en cambio, se refiere a la **inflamación superficial de la mucosa gástrica**, que puede ser aguda o crónica, y que comparte factores etiológicos y fisiopatológicos con la úlcera péptica.

En Chile, *Helicobacter pylori* (*H. pylori*) es prevalente en aproximadamente **50–60 % de la población adulta**, y representa la principal causa de úlcera péptica y gastritis crónica.

Los AINEs y el ácido acetilsalicílico son el segundo factor etiológico más importante, especialmente en adultos mayores.

En el **EUNACOM**, este tema es clásico y se pregunta frecuentemente por:

- Diagnóstico diferencial entre dispepsia funcional, gastritis y úlcera péptica.
- Indicación de endoscopia.
- Tratamiento erradicador de *H. pylori* según guías nacionales.
- Complicaciones y prevención.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Mecanismos normales de defensa gástrica

La mucosa gástrica está protegida por:

- **Capa de moco y bicarbonato**, que crea un microambiente neutro.
- **Prostaglandinas**, que estimulan secreción de moco y flujo sanguíneo.
- **Renovación epitelial rápida**.

El equilibrio entre estos mecanismos y los factores agresivos determina la integridad mucosa.

2.2. Factores agresivos

- **Ácido clorhídrico y pepsina**: el exceso ácido o la disminución de la barrera mucosa favorecen la lesión.
- **Helicobacter pylori**: bacteria gramnegativa espiralada que coloniza la mucosa gástrica, secreta ureasa, que neutraliza el ácido y daña el epitelio mediante toxinas (CagA, VacA), generando inflamación crónica.
- **AINEs y aspirina**: inhiben la ciclooxigenasa (COX-1), reduciendo prostaglandinas protectoras.
- **Tabaquismo y alcohol**: disminuyen la perfusión y cicatrización mucosa.
- **Estrés fisiológico severo**: en pacientes críticos, puede inducir “úlceras de estrés”.

2.3. Gastritis y úlcera péptica

- **Gastritis aguda**: inflamación súbita, asociada a AINEs, alcohol o infecciones.
- **Gastritis crónica**: inflamación persistente por *H. pylori* o autoinmunidad (gastritis tipo A).

- **Úlcera gástrica:** más frecuente en curvatura menor y antro; puede asociarse a hipoclorhidria o malignidad.
 - **Úlcera duodenal:** más común en bulbo duodenal; suele acompañarse de hipersecreción ácida.
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Síntomas principales

El síntoma cardinal de la úlcera péptica es la **dispepsia**, caracterizada por:

- Dolor epigástrico tipo quemante o urente.
- Relación con las comidas:
 - **Úlcera duodenal:** dolor que **mejora al comer** y reaparece 2–3 h después.
 - **Úlcera gástrica:** dolor que **aumenta con la ingesta**.
- Náuseas, saciedad precoz, distensión abdominal.
- En casos complicados: hematemesis, melena o signos de anemia.

3.2. Signos de alarma (“síntomas de alarma”)

Indicadores de patología orgánica o cáncer gástrico:

- Baja de peso no intencionada.
- Anemia ferropénica.
- Hematemesis o melena.
- Vómitos persistentes.

- Disfagia u odinofagia.
- Antecedente familiar de cáncer gástrico.

En presencia de estos signos, se **indica endoscopía urgente**.

3.3. Diagnóstico diferencial

- **Dispepsia funcional:** síntomas sin lesión orgánica; frecuente en jóvenes.
 - **Cáncer gástrico:** úlcera irregular, anémica, refractaria o con signos de alarma.
 - **Gastritis erosiva:** dolor leve y difuso, sin úlcera profunda.
 - **Pancreatitis crónica:** dolor epigástrico irradiado a dorso.
 - **Colelitiasis:** dolor postprandial en hipocondrio derecho.
-

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Endoscopía digestiva alta (EDA)

Es el **método diagnóstico de elección** para úlcera péptica y gastritis.

Permite visualizar directamente la lesión, tomar biopsias y descartar malignidad.

Toda **úlcera gástrica** debe biopsiarse para excluir cáncer, incluso si parece benigna.

4.2. Diagnóstico de *H. pylori*

- **Test rápido de ureasa** (biopsia endoscópica): resultado en minutos.

- **Histología gástrica:** permite confirmar infección y evaluar inflamación.
- **Test de aliento con urea marcada (C13 o C14):** alta sensibilidad, ideal para control post-tratamiento.
- **Antígeno fecal:** alternativa no invasiva útil en seguimiento.
- **Serología:** detecta anticuerpos, pero no distingue infección activa.

4.3. Otros exámenes

- Hemograma: anemia microcítica por sangrado crónico.
 - Pruebas hepáticas y amilasemia: descartar diagnósticos diferenciales.
 - Radiografía contrastada: actualmente en desuso, reemplazada por endoscopía.
-

5. Tratamiento

El objetivo del tratamiento es **erradicar H. pylori, cicatrizar la úlcera, aliviar síntomas y prevenir recurrencias o complicaciones.**

5.1. Medidas generales

- Suspendir AINEs, aspirina y corticoides si es posible.
 - Evitar tabaco y alcohol.
 - Dieta fraccionada, evitando irritantes gástricos.
 - Control del estrés y manejo psicológico en dispepsia funcional.
-

5.2. Erradicación de *Helicobacter pylori*

Esquema triple (primera línea, MINSAL 2023):

- Omeprazol 20 mg cada 12 h.
- Amoxicilina 1 g cada 12 h.
- Claritromicina 500 mg cada 12 h.

Duración: **14 días.**

Esquema cuádruple con bismuto (segunda línea o resistencia a claritromicina):

- IBP cada 12 h.
- Subsalicilato de bismuto 120 mg cada 6 h.
- Metronidazol 500 mg cada 8 h.
- Tetraciclina 500 mg cada 6 h.

Duración: **10–14 días.**

Confirmación de erradicación:

4–6 semanas después, mediante **test de aliento o antígeno fecal**, suspendiendo IBP 2 semanas antes del test.

5.3. Tratamiento de la úlcera no relacionada con *H. pylori*

- IBP por 4–8 semanas (omeprazol, pantoprazol o esomeprazol).
- Si uso de AINEs es imprescindible → asociar IBP o reemplazar por inhibidor COX-2.
- Profilaxis en pacientes de alto riesgo (mayores de 65 años, anticoagulados).

5.4. Tratamiento de la gastritis

- En gastritis aguda por AINEs o alcohol → suspensión del agente y uso de IBP o anti-H2 por 2–4 semanas.
- En gastritis crónica por *H. pylori* → erradicar la infección.
- En gastritis autoinmune → manejo de la anemia perniciosa (vitamina B12 parenteral).

5.5. Tratamiento de complicaciones

- **Hemorragia digestiva:** manejo endoscópico con adrenalina, clips o coagulación.
- **Perforación:** urgencia quirúrgica.
- **Obstrucción pilórica:** puede requerir dilatación endoscópica o cirugía.

6. Complicaciones y pronóstico

6.1. Complicaciones

- **Hemorragia digestiva alta:** es la más frecuente, ocurre por erosión vascular.
- **Perforación gástrica o duodenal:** dolor súbito, abdomen rígido, aire libre subdiafragmático (neumoperitoneo).
- **Obstrucción pilórica:** por edema o cicatrización crónica.

- **Malignización:** especialmente en úlceras gástricas crónicas o gastritis atrófica autoinmune.

6.2. Pronóstico

Con tratamiento adecuado, la tasa de curación supera el **90 %**.

La recurrencia es baja tras erradicación de *H. pylori*.

El pronóstico empeora en pacientes con uso continuo de AINEs o edad avanzada.

7. Prevención

1. **Erradicar *H. pylori* en pacientes sintomáticos o con antecedentes de úlcera.**
 2. **Uso racional de AINEs y antiagregantes:** siempre asociar IBP en pacientes de riesgo.
 3. **Evitar tabaco, alcohol y comidas irritantes.**
 4. **Control periódico en pacientes con úlcera gástrica:** repetir endoscopía para confirmar cicatrización.
 5. **Profilaxis con IBP** en pacientes críticos para prevenir úlceras de estrés.
-

8. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas:

1. *H. pylori* es la causa más frecuente de úlcera péptica y gastritis crónica.
2. El diagnóstico de elección es **endoscopía digestiva alta con biopsia**.

3. El tratamiento de primera línea es el **esquema triple con IBP + amoxicilina + claritromicina** por 14 días.
4. La **confirmación de erradicación** se hace con test de aliento o antígeno fecal.
5. En **pacientes que usan AINEs**, siempre asociar un IBP.
6. La **recurrencia** tras erradicación exitosa de *H. pylori* es excepcional.
7. En úlcera gástrica, siempre **biopsiar para descartar malignidad**.

Errores comunes:

- Tratar gastritis sin buscar *H. pylori*.
- No confirmar erradicación tras tratamiento.
- Prescribir IBP por tiempo indefinido sin indicación.
- Omitir biopsia en úlcera gástrica.
- Indicar dieta estricta innecesaria o prohibiciones exageradas.

9. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **úlcera péptica** es una lesión mucosa profunda causada por *H. pylori* o AINEs, y la **gastritis** es la inflamación superficial de la mucosa gástrica.
2. El síntoma cardinal es la **dispepsia epigástrica**, con dolor relacionado con las comidas.
3. El diagnóstico se confirma con **endoscopía digestiva alta y biopsia para *H. pylori***.

4. El tratamiento de primera línea es el **esquema triple con IBP + amoxicilina + claritromicina** durante 14 días.
5. Los **IBP son fundamentales** para la cicatrización y prevención de recurrencias.
6. Toda **úlcera gástrica debe biopsiarse** para descartar cáncer.
7. La **prevención** se basa en erradicar *H. pylori*, usar racionalmente AINEs y asociar IBP en pacientes de riesgo.